

Il Corpo Alessitimico

Salute Mentale · Sessione 12 · 2026

Questa lezione affronta uno dei costrutti più affascinanti e praticamente utili del modulo: l'alessitimia. Non saper dare un nome alle proprie emozioni può sembrare una difficoltà astratta, ma le sue conseguenze — sul corpo, sulle relazioni, sulla dipendenza — sono concretissime. Preparati a capire perché il linguaggio emotivo non è un lusso, ma una funzione vitale.

La Regolazione Affettiva: le fondamenta

Tutto parte da una domanda semplice: cosa significa *regolare* le emozioni? Non vuol dire sopprimerle — vuol dire esprimerle in modo congruo al contesto, con l'intensità giusta, al momento giusto.

Le emozioni che proviamo e mostriamo sono già l'esito di un processo, in gran parte inconsapevole, di autoregolazione che ne modula la natura, l'intensità e le manifestazioni. (Matarazzo & Zammuner, 2015)

Già **Aristotele** si era posto il problema: gli affetti possono essere dannosi se non moderati. La sua soluzione era collocarli "tra l'eccesso e la scarsità". I filosofi stoici, al contrario, ritenevano che la ragione dovesse prendere il controllo totale sulle emozioni.

Oggi sappiamo che nessuno dei due estremi funziona. Le emozioni servono — e la loro regolazione si apprende.

Come impariamo a regolare le emozioni

Il bambino non nasce con questa capacità: all'inizio è il **caregiver** a regolare le emozioni per lui. Progressivamente il bambino acquisisce tre competenze fondamentali:

1. **Verbalizzazione**: imparare a dare un nome a quello che sente
2. **Desomatizzazione**: capire che la sensazione corporea (tachicardia, calore, tremore) non è solo un fatto fisico, ma segnala un'emozione
3. **Autoregolazione**: gestire da solo l'intensità e l'espressione delle emozioni

Esempio della docente: sento il cuore accelerato e le guance calde prima di una lezione. Se sono in grado di desomatizzare, capisco che non è una tachicardia cardiologica — è l'emozione dell'entrare in aula. Una persona con alessitimia grave invece pensa: "Probabilmente ho un problema al cuore, devo andare al pronto soccorso."

Attenzione: le persone alessitimiche *provano* le emozioni — sbagliato dire che non le sentono. Il problema è che non riescono a collegare le sensazioni corporee all'emozione corrispondente, e quindi non riescono a darle un nome.

L'Intelligenza Emotiva secondo Salovey e Mayer

Prima di entrare nell'alessitimia, è utile capire cosa significa avere una buona gestione emotiva. Esiste non solo un Q.I. (intelligenza intellettiva) ma anche un **Q.E.** (quoziente emotivo).

Intelligenza emotiva (Salovey e Mayer): coinvolge l'abilità di percepire, valutare ed esprimere un'emozione; l'abilità di accedere a sentimenti e/o crearli quando facilitano i pensieri; l'abilità di capire l'emozione e la conoscenza emotiva; e l'abilità di regolare le emozioni per promuovere la crescita emotiva e intellettuale. (Zappa et al., 2011, p.68)

Salovey e Mayer hanno suddiviso l'intelligenza emotiva in **quattro dimensioni**, ognuna delle quali corrisponde a una fase dello sviluppo emozionale — come un livello di un videogioco che si sblocca progressivamente:

#	Dimensione	Cosa significa
1	Percezione, valutazione ed espressione delle emozioni	Riconoscere le proprie emozioni (anche dal corpo), riconoscerle negli altri, esprimerle in modo appropriato
2	Facilitazione emozionale del pensiero	Usare le emozioni come guida per decisioni, memoria, creatività
3	Comprensione e analisi delle emozioni	Dare un nome alle emozioni, capire le emozioni complesse e miste, riconoscere le transizioni tra emozioni
4	Regolazione consapevole delle emozioni	Gestire le emozioni in sé e negli altri, rimanere "dentro" o prendere le distanze in modo deliberato

Queste quattro dimensioni sono in ordine cronologico: corrispondono agli stadi dello sviluppo emozionale dalla prima infanzia fino all'adolescenza. Chi non riesce a raggiungere le fasi più avanzate avrà difficoltà con la regolazione consapevole — il territorio dell'alessitimia.

La docente usa *Inside Out* come esercizio pratico: la bambina nel film non è ancora in grado di regolare da sola le emozioni (lo fa la mamma/papà), ma le emozioni guidano già le sue scelte — siamo alla dimensione 1 e 2.

Il Costrutto di Alessitimia

Fin qui ci siamo? Bene — ora arriva la parte centrale.

Alessitimia: termine coniato nel 1973 da Peter Sifneos, psichiatra di Harvard. Dal greco: *a* (mancanza) + *lexis* (parole) + *thymos* (emozione) = mancanza di parole per le emozioni. Incapacità di esprimere verbalmente le proprie emozioni.

Il percorso storico del costruito:

- **1948 — Ruesch**: descrive pazienti con personalità infantile e deficit di espressione simbolica degli affetti, con espressione attraverso l'azione e disturbi somatici.
- **1949 — MacLean**: difficoltà a esprimere verbalmente le emozioni nei pazienti psicosomatici.
- **1963 — Marty e M'Uzan**: definiscono il **pensiero operatorio** — modo di pensare utilitaristico, senza fantasia; la persona sembra testimone piuttosto che attore della propria vita.
- **1973 — Sifneos**: conia il termine alessitimia.
- **1994 — Taylor**: formula la definizione aggiornata (quella da sapere per l'esame).

Le caratteristiche dell'alessitimia secondo Taylor

L'alessitimia si caratterizza per quattro aspetti centrali:

1. **Difficoltà a discriminare le emozioni tra loro** e distinguerle dalle sensazioni somatiche
2. **Vocabolario emotivo limitato** — difficoltà a comunicare verbalmente le proprie emozioni agli altri
3. **Attività fantasmatica deficitaria o assente** — poca immaginazione, tutto sul concreto
4. **Stile cognitivo orientato verso l'esterno** — poco introspettivo (Taylor et al., 2014)

A queste si aggiungono altre caratteristiche cliniche:

- Tendenza al **conformismo sociale** (deve avere la bella casa, il bel lavoro — corrispondere alle aspettative)
- **Predisposizione all'azione** piuttosto che all'autoriflessione (agiti, lanciare oggetti, sbattere porte)
- **Postura rigida e povertà dell'espressione facciale** (il sorriso "appiattito" che non coinvolge gli occhi)

- **Ridotta capacità empatica** — se non riconosco le mie emozioni, fatico a riconoscere quelle degli altri
- **Scarso ricordo dei sogni** — quando li ricordano, spesso contengono violenza agita o subita

Esempio della docente: la persona alessitimica torna dalla vacanza e racconta — in modo preciso — ogni logistica: orario di partenza, check-in, volo, hotel. Ma se gli chiedi "com'è stata?", manca tutta la componente emotiva. Come sentire il telegiornale: informazioni senza emozione.

La docente usa Cameron Diaz nel film "L'amore non va in vacanza" come caso illustrativo: litiga col fidanzato e invece di confrontarsi con le emozioni della rottura razionalizza tutto ("abbiamo fatto bene a non sposarci"). Somatizza con spasmi esofagei. Non piange. Tutto molto concreto, niente introspezione.

Alessitimia di tratto vs alessitimia di stato

Distinzione fondamentale per l'esame e per l'intervento:

Tipo	Origine	Caratteristiche
Di tratto	Problema nello sviluppo emozionale infantile	Accompagna la personalità in modo stabile; è il modo di funzionare della persona
Di stato	Conseguenza di un trauma	Subentra a uno sviluppo emozionale normale; è potenzialmente reversibile con l'elaborazione del trauma

Questa distinzione è cruciale: con l'alessitimia di stato si lavora sull'elaborazione del trauma. Con quella di tratto si usano canali alternativi al verbale — musicoterapia, arteterapia, teatro — e oggi la ricerca dimostra che si può lavorare con risultati positivi anche in questo caso.

L'alessitimia come costrutto transnosografico

L'alessitimia non è una diagnosi in sé, ma un costrutto transnosografico (o transdiagnostico): si ritrova in quasi tutti i quadri clinici del modulo.

Si trova in: - Disturbi psicosomatici - Disturbi dell'umore (inclusa la depressione mascherata, dove la sofferenza si esprime solo attraverso sintomi fisici) - Disturbi d'ansia - Dipendenze da sostanze - Disturbi alimentari - Disturbi di personalità

Transnosografico *non* significa che tutti i pazienti con una data diagnosi abbiano tratti alessitimici. Significa che l'alessitimia *può essere presente* in tutti questi quadri. Non è un'equazione automatica.

Eccezione importante: l'alessitimia *non* si ritrova nelle psicosi. Secondo Krystal, se il bambino traumatizzato nega la realtà sviluppa psicosi; se nega la fantasia ancorandosi alla realtà, sviluppa tratti alessitimici. Sono due esiti opposti.

La Misurazione dell'Alessitimia

Strumenti clinici validati per misurare il costrutto:

Strumento	Nome completo	Caratteristiche
TAS-20	Toronto Alexithymia Scale	20 item, autovalutazione su scala Likert; misura le 3 dimensioni principali; standardizzata anche per adolescenti (dai 12 anni); più usata nella ricerca
SAR	Scala Alessitimica Romana	Aggiunge empatia e dimensione somatica alle 3 dimensioni principali
TSIA	Toronto Structured Interview for Alexithymia	Formato intervista; indaga anche fantasia e processi immaginativi

Bagby et al. (2020) hanno rivisto 25 anni di letteratura sulla TAS-20, concludendo che è uno strumento affidabile e valido che riflette accuratamente il costrutto come definito originariamente da Nemiah et al. nel 1976.

Le scale non fanno diagnosi — sono campanelli d'allarme. L'alessitimia non è una diagnosi autonoma nel DSM o nell'ICD.

Alessitimia e Trauma

Henry Krystal, psicanalista polacco e sopravvissuto a un campo di concentramento, è stato uno dei grandi esperti di questo collegamento. Lui i traumi li ha vissuti in prima persona — e poi li ha studiati.

Krystal distingue due tipi di trauma:

- **Trauma infantile:** influisce sui precursori affettivi del bambino, blocca lo sviluppo di desomatizzazione e verbalizzazione delle emozioni, impatta le funzioni simboliche.
- **Trauma adulto:** consiste in un passaggio progressivo dall'ansia alla passività catatonica.

Modello di risposta al pericolo (Krystal, 2004)

Pericolo

└→ Pericolo evitabile → reazione affettiva (paura, ansia, terrore)

└→ Pericolo inevitabile → reazione catatonica → passività catalet

Nello stato catatonico, paradossalmente, il congelamento degli affetti procura sollievo: la persona non sente le emozioni sgradevoli (terrore, paura). Per questo viene spesso descritta come fredda, razionale, indifferente.

Come il trauma infantile porta all'alessitimia

Un vissuto traumatico si crea nel bambino quando:

1. Il caregiver lascia che le emozioni raggiungano un livello di **intollerabilità** (non regola regolarmente l'emozione del bambino)
2. Il processo di **disillusione** (Winnicott) avviene troppo precocemente — il bambino viene confrontato con frustrazioni che non è ancora in grado di tollerare

Il bambino che non riesce più a distinguere fantasia da realtà ha due strade: - **Nega la realtà** → psicosi - **Nega la fantasia**, ancorandosi solo alla realtà → **alessitimia**

L'alessitimia può essere mantenuta nel tempo se il trauma non viene elaborato o se il contesto non lo permette. Tra i sopravvissuti a eventi traumatici, diversi ricercatori hanno riscontrato disturbi psicosomatici.

Alessitimia e Dipendenze Patologiche

L'essere umano nasce dipendente. Crescendo dovrebbe sviluppare una dipendenza *sana* — relazionarsi con gli altri, condividere emozioni, mantenere la giusta distanza affettiva. Alcune persone non ci riescono:

- Alcune riducono la distanza fino alla relazione morbosa con l'Altro
- Altre la aumentano fino all'isolamento affettivo
- Altre ancora usano le **sostanze psicotrope come stampella chimica** per regolare le proprie emozioni

Le dipendenze patologiche hanno eziologia multifattoriale (biologica, personale, socioculturale), ma molti studi concordano che trovano origine anche in un disturbo della regolazione affettiva.

Persone con dipendenza da sostanze tendono a provare gli affetti in modo indifferenziato e prevalentemente somatico, senza riuscire a usarli come segnale. La sostanza diventa un mezzo per bloccare le sensazioni sgradevoli.

Wurmser (1974) e Khantzian (1982) hanno descritto che per i dipendenti gli affetti difficili da regolare possono essere sia quelli intensi e dolorosi che quelli vaghi e diffusi. Il problema centrale è la mancanza di controllo sui propri affetti.

Svanito l'effetto della sostanza, essa porta a un peggioramento del disagio (Taylor et al., 2007) — il circolo si chiude su se stesso.

Il ruolo dell'attaccamento

Krystal e Khantzian ritengono che l'eziologia dei disturbi della regolazione affettiva vada ricercata in relazioni disfunzionali nell'infanzia. L'attaccamento sicuro è fondamentale per sviluppare una sana interdipendenza nelle relazioni.

Diversi studi hanno riscontrato in pazienti con dipendenza da sostanze forme di **attaccamento insicuro** (evitante o misto).

Il modello psicodinamico dell'addiction (Caretto & La Barbera, 2005)

Disturbo dell'attaccamento o trauma

→ Incapacità di regolare le emozioni

→ Realtà percepita come minacciosa

→ Stato dissociativo tramite sostanze psicotrope

Cruise e Becerra (2018) hanno svolto una revisione critica su "Alexithymia and problematic alcohol use", analizzando studi dal 2009 al 2016. L'alessitimia è risultata un fattore di rischio indipendente per i problemi legati all'alcol in campioni clinici, mediata da fattori come craving, pensieri intrusivi e motivi di consumo.

Concetti chiave

Termine	Significato
Alessitimia	Incapacità/difficoltà di dare un nome alle proprie emozioni e di distinguere sensazioni corporee da stati emotivi

Termine	Significato
Desomatizzazione	Processo per cui il bambino impara a collegare la sensazione corporea all'emozione, non a considerarla solo un fatto fisico
Pensiero operatorio	Modo di pensare concreto, utilitaristico, privo di fantasia — tipico dei pazienti psicosomatici (Marty e M'Uzan)
Costrutto transnosografico	Costrutto che si ritrova trasversalmente in molte diagnosi diverse, senza essere una diagnosi autonoma
Alessitimia di tratto	Legata allo sviluppo, stabile nel tempo, parte del modo di funzionare della persona
Alessitimia di stato	Consequente a un trauma, potenzialmente reversibile con l'elaborazione del trauma
TAS-20	Toronto Alexithymia Scale — strumento di autovalutazione a 20 item, più usato nella ricerca
Intelligenza emotiva	Insieme di abilità (Salovey e Mayer) per percepire, usare, comprendere e regolare le emozioni
Addiction	Dipendenza patologica — spesso connessa a disturbi della regolazione affettiva e alessitimia

Domande di orientamento allo studio

Cos'è l'alessitimia e da dove deriva il termine? L'alessitimia è un costrutto che descrive l'incapacità o la difficoltà di una persona a identificare, descrivere e comunicare verbalmente le proprie emozioni. Il termine è stato coniato nel 1973 da Peter Sifneos, psichiatra di Harvard, e deriva dal greco: *a* (mancanza), *lexis* (parole), *thymos* (emozione). Non è una diagnosi autonoma, ma un costrutto transnosografico presente in numerosi quadri clinici.

Quali sono le quattro caratteristiche principali dell'alessitimia secondo Taylor? Secondo Taylor (1997), l'alessitimia si caratterizza per: (1) difficoltà a discriminare le emozioni tra loro e a distinguerle dalle sensazioni somatiche; (2) vocabolario emotivo limitato, con notevole difficoltà a comunicare verbalmente le proprie emozioni; (3) attività fantasmatica deficitaria o assente; (4) stile cognitivo orientato verso l'esterno, poco introspettivo. Si aggiungono clinicamente: rigidità posturale, povertà espressiva, conformismo sociale, predisposizione all'azione (agiti) e ridotta empatia.

Qual è la differenza tra alessitimia di tratto e alessitimia di stato?

L'alessitimia di tratto è legata a un problema nello sviluppo affettivo infantile: accompagna la personalità della persona in modo stabile ed è il suo modo di funzionare. L'alessitimia di stato è invece conseguente a un trauma subito, anche in età adulta; può subentrare in una persona che aveva uno sviluppo emotivo normale e, con l'elaborazione del trauma, è potenzialmente reversibile. La distinzione è fondamentale perché orienta le scelte di intervento.

Perché l'alessitimia è definita costrutto transnosografico e in quale quadro clinico non si ritrova? Viene definita transnosografica perché si riscontra in moltissimi quadri clinici: disturbi psicosomatici, dell'umore, d'ansia, dipendenze, disturbi alimentari, disturbi di personalità. L'unico quadro in cui *non* si ritrova è la psicosi: secondo Krystal, il bambino traumatizzato che nega la realtà sviluppa psicosi, mentre quello che nega la fantasia sviluppa tratti alessitimici — esiti opposti.

In che modo il trauma infantile può portare all'alessitimia? Secondo Krystal, l'alessitimia infantile si sviluppa quando il caregiver non riesce regolarmente ad aiutare il bambino a regolare le emozioni (lasciandole raggiungere livelli intollerabili) oppure quando il processo di disillusione descritto da Winnicott avviene troppo precocemente. In questi casi il bambino fatica a distinguere realtà da fantasia: se nega la fantasia ancorandosi alla realtà, svilupperà tratti alessitimici.

Qual è il collegamento tra alessitimia e dipendenze patologiche? Le dipendenze patologiche hanno eziologia multifattoriale, ma molti studi concordano sulla presenza di un disturbo della regolazione affettiva. Le persone con dipendenza tendono a provare gli affetti in modo indifferenziato e prevalentemente somatico, e

usano la sostanza come mezzo per bloccare le sensazioni sgradevoli. Wurmser e Khantzian hanno descritto come la mancanza di controllo sugli affetti sia la fonte della sofferenza. Cruise e Becerra (2018) hanno confermato l'alessitimia come fattore di rischio indipendente per il consumo problematico di alcol.

Collegamenti

- **Lezioni precedenti:** riprende i disturbi dell'umore (depressione mascherata), i disturbi d'ansia, i modelli di attaccamento di Bowlby e le teorie di Winnicott sulla disillusione.
- **Lezione 11 / sindromi affettive:** le emozioni di Ekman (fiore di Plutchik), base per capire cosa significa "non riconoscere" le proprie emozioni.
- **Inside Out:** usato come esercizio durante la lezione per riconoscere le quattro dimensioni dell'intelligenza emotiva nel corso dello sviluppo.
- **"L'amore non va in vacanza":** usato come caso illustrativo del funzionamento alessitimico (Cameron Diaz).
- **Temi aperti:** musicoterapia, arteterapia e teatro come canali alternativi per lavorare con persone con alessitimia di tratto; legame con la violenza agita (lezione successiva).